

Diagnóstico diferencial — Ansiedad

Adaptativa vs. patológica, y entre subtipos

La ansiedad es una respuesta adaptativa universal. Se vuelve clínicamente relevante cuando es desproporcionada, persistente y limita el funcionamiento. Esta tabla orienta la diferenciación inicial entre subtipos frecuentes.

TIPO	DURACIÓN	FOCO DEL MIEDO	EVITACIÓN CARACTERÍSTICA
Ansiedad adaptativa	Horas/días	Amenaza real, identificable	Resuelve la causa y se disipa; no genera evitación generalizada.
TAG	≥6 meses	Múltiples áreas de la vida	Evitación cognitiva (preocuparse como intento de 'controlar').
Trastorno de pánico	Crisis agudas, recurrentes	Las sensaciones físicas mismas	Evitación de lugares/situaciones asociadas a crisis previas.
Fobia específica	Persistente, ≥6 meses	Objeto o situación específica	Evitación muy focalizada al estímulo temido.
Ansiedad social	Persistente, ≥6 meses	Evaluación o juicio de otros	Evitación de situaciones sociales/de desempeño.

■ Clave clínica

La pregunta clínica clave no es 'cuánto miedo' sino 'cuánto limita la vida'. Descartar siempre causa médica (tiroides, arritmias, cafeína/estimulantes) antes de confirmar un trastorno de ansiedad primario.